

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	甲狀腺腫瘤術後的照護 Postoperative Care of Thyroid Tumor				
編號	A31000-Q03-W-K23	制定者	N11 莊淑娟	公布日期	102 年 03 月 08 日
制定單位	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	113 年 12 月 17 日
版本/總頁數	第 1.7 版/8 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	114 年 10 月 02 日

一、目的

讓護理人員了解甲狀腺腫瘤術後的照護。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

甲狀腺腫瘤是由於甲狀腺體過度發展成結節，這些結節大都是良性，但也有可能轉變成惡性。主要是幼兒期及兒童期在頭部或頸部曾接受過大劑量放射照射所導致，其他危險因子還包括食物中的碘缺乏或過量，以及某些基因變異，其中有小部分的人與家族性基因突變有密切關係。

（二）症狀

聲音嘶啞或飲水時嗆咳；呼吸困難或吞嚥困難；耳、枕、肩部有放射性疼痛；頸部靜脈受壓擴張或出現眼凸、瞳孔縮小；同側或雙側淋巴結腫大等。在全身性影響方面，主要是與甲狀腺荷爾蒙有關，如果功能低下，如橋本氏甲狀腺炎，病人可能有怕冷、便秘、虛胖、倦怠、皮膚乾冷、心博過慢等現象。如果功能亢進，病人可能有怕熱，排便次數增加，甚至腹瀉、心跳過快、手顫抖、急躁、食慾增加等現象。

（三）常見檢查

- 1.觸診檢查：可摸到結節、硬塊。
- 2.甲狀腺超音波檢查：可得到較低且不同性質的回音，或見到一個一個的結節。

主題名稱	甲狀腺腫瘤術後的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K23	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	2/8

3. 甲狀腺細針抽吸細胞學檢查。

4. 測量血清 T3、T4、甲狀腺刺激素(TSH)及 Free T4 的濃度。

(四) 常見治療

1. 藥物治療：利用甲狀腺荷爾蒙來抑制甲狀腺繼續腫大。

2. 手術治療：全葉或次全葉甲狀腺切除。

3. 放射線治療：手術後加上放射線碘 131 治療，可預防遠端轉移，並根除未清除乾淨的腫瘤。

4. 甲狀腺射頻消融術(radiofrequency ablation, RFA)為一個有效且安全的治療。目前的臨床運用以良性甲狀腺腫瘤為主，但也可作為復發的甲狀腺惡性腫瘤替代療法。

5. 手術後給予較高劑量甲狀腺素，以抑制腦下垂體分泌 TSH，進而抑制甲狀腺瘤的再生、復發。

(五) 護理問題

1. 尋求(特定的)健康協助/與手術前後知識不足有關

2. 易感染/與手術傷口有關

(六) 護理措施

1. 尋求(特定的)健康協助/與手術前後知識不足有關

(1)提供病人手術後護理措施：

A. 依醫囑測量生命徵象，若脈搏增快、呼吸困難，可能是傷口血腫壓迫氣管，病床旁應備氣管切開包，以備緊急之用。

B. 檢視傷口敷料，可用手觸摸頸後，確定有無出血。

C. 讓病人採半坐臥式，以防牽扯到傷口縫線。

D. 監測體溫變化，因體溫升高可能是甲狀腺風暴的徵象。

E. 每 1-2 小時，與病人談話一次，若聲音嘶啞、微弱，乃為單側喉返神經損傷，告訴病人數天後即會恢復，若二側喉返神經損傷，病人聲音就會發不出來。

若聲音變細，並感到呼吸困難，應立即通知醫師做氣管切開術。

F. 鼓勵病人行深呼吸、咳嗽運動，以清除呼吸道分泌物。

主題名稱	甲狀腺腫瘤術後的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K23	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	3/8

G. 視病人忍受度，可讓其由口攝食，一般在手術後第 2 天，即可進食冰飲、軟質飲食。

H. 若有留置引流管，請勿牽扯，以保持引流管通暢。

I. 傷口癒合後（約手術後 2-4 天），在醫師許可下，教導病人執行頭部關節運動（點頭、仰頭、左右轉動頭部），伸展頸部以防發生攣縮。

(2)合併症護理

A. 出血：出血伴呼吸困難多發生於術後 24-48 小時內。採取的護理措施為：

(A)術前對病人及家屬進行衛教，緩解病人與家屬的焦慮。

(B)術後協助病人採半臥位，有利於病人的呼吸及引流傷口內積血。

(C)做好術後衛教，教導病人術後 48 小時內避免頸部過度活動和過多講話，以預防傷口出血。

(D)注意保持引流管通暢。

(E)術後 48 小時內密切觀察病人的呼吸頻率和節律、體溫、脈搏、血壓及頸部傷口滲血情況，每 1-2 小時監測一次，並注意是否有頸部腫脹。

(F)教導病人正確咳嗽方法，鼓勵咳嗽、咳痰，協助翻身、叩背，促進排痰。

(G)禁食 6 小時，術後 3 天內勿吃過熱飲食，以避免因熱食造成血管擴張，而導致傷口出血。

(H)備氣管切開包及無菌手套於床旁桌上，以備急用。

B. 喉返神經損傷：一側喉返神經損傷可能引起聲音嘶啞，雙側喉返神經損傷可導致失音或嚴重的呼吸困難，甚至窒息，須立即做氣管切開。採取的護理措施是：

(A)當病人術後回病房時，如麻醉已清醒，立即誘導病人說話，以了解有無喉返神經損傷。

(B)對於術後出現聲音嘶啞者，應做好解釋工作，偶爾會有發音失常，這通常是因為麻醉插管引起的一種喉炎，而且常幾週或可能至幾月會消失。

C. 副甲狀腺損傷：副甲狀腺損傷可導致副甲狀腺功能低下，此併發症為甲狀

主題名稱	甲狀腺腫瘤術後的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K23	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	4/8

腺癌手術嚴重的併發症，可導致嚴重的低鈣血症，需終生服用鈣劑。採取的護理措施為：

(A)術後 1-3 天特別注意觀察病人是否出現面部、口唇周圍或手、足針刺感、麻木感甚至強直感，重者可能有手足陣發性痙攣、抽搐等。

(B)加強心理護理，做好安慰、解釋工作，使病人能夠積極主動配合治療。

(C)病人要特別注意飲食控制，限制含磷較高的食物，如牛奶、瘦肉、蛋黃、魚類等，因副甲狀腺素(PTH)，其生理功能是調節體內鈣質的代謝並維持鈣和磷的平衡，當血磷增高時，會影響鈣的吸收導致血鈣進一步降低而加重病情。根據病情給予口服（咀嚼碎後服用）或靜脈補充鈣劑，必要時加用活性維生素 D3，以促進鈣在腸道的吸收。

(D)採酸性灰(Acid-Ash)食物（如：五穀類、肉類、蛋類、李子、梅子），以維持酸性尿，減少腎結石發生。

2.易感染/與手術傷口有關

(1)引流管護理

A. 定時觀察引流液的量及顏色性質，術後 1 小時內引流液為 10-20ml，如果短時間內引流液突然增加超過 100ml，色鮮紅，應懷疑為內出血，要迅速協助醫生做好緊急處理。

B. 一般情況下術後 24 小時內引流液量為 20-120ml，顏色由深紅色逐漸轉為淡紅色。術後 24-48 小時，引流液顏色由淡紅色逐漸轉為淡黃色，引流量逐漸減少。

C. 注意觀察引流管有無漏氣情況，有慢性滲血可給予壓迫止血或放置冰袋冷敷，肌肉或靜脈注射止血藥。避免引流管扭曲、壓迫、阻塞和脫出，確保有效負壓。負壓引流管通常平放於床頭，別針固定。

(2)監測生命徵象，注意有無發燒情形。

(3)觀察傷口有無炎症反應，並指導家屬及病人自行觀察傷口外觀。

(4)指導病人及家屬了解傷口發炎之症狀，例如:紅、腫、熱、痛。

(5)放置引流管病人，其傷口有滲濕時，應依無菌技術協助傷口消毒換藥。

主題名稱	甲狀腺腫瘤術後的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K23	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	5/8

(6)病人可進食後應指導採高熱量、高蛋白飲食，促進傷口癒合。

(7)教導保持傷口乾燥及清潔，且避免壓迫傷口。

(8)教導感染的危險因子及預防感染的重要性。

(七)衛教指導

- 1.依醫師指示回診，避免接觸感染病人尤其是上呼吸道感染的病人（感冒），如有症狀應返診；若甲狀腺全切除，需六週內返院做掃描檢查。
- 2.出院返家後如有傷口滲血，疼痛不適、吞嚥困難、喉頭緊縮、發燒等不適，應速返院就醫。
- 3.請依醫師指示服藥，服藥時請注意時間、藥量、用法及其連續性。
- 4.病人若口服甲狀腺素補充劑做替代治療，指導病人服用過程中如出現心悸等不適，應及時到醫院就診調節服藥劑量。
- 5.避免情緒過度激動，尤其是憤怒、發脾氣等；保持身心愉快，方可恢復工作。
- 6.返家後應採均衡飲食及避免含碘食物，如紫菜、海帶及海中之葉菜類。
- 7.洗頭時勿過度前傾或後仰；注意聲音是否沙啞，減少說話機會。
- 8.出院時衛教病人保持傷口清潔，預防感染。
- 9.部份病人顧慮傷口疤痕影響外型美觀，因此，心理護理也是病人術後護理的重要環節，了解病人的人格特徵、心理反應及對疾病的態度，耐心地做好心理輔導，消除緊張情緒，降低焦慮和抑鬱。
- 10.若為惡性腫瘤採取放射線 I131 來治療的病人，因病人的尿液、唾液（食用器皿、牙刷及嘔吐物）和汗液等都是放射性污染源，應於返家後注意下列事項：
 - (1)第一週與旁人相隔距離至少一公尺，且時間在一小時內。其餘時間最好保持在兩公尺以上的距離。第二週與旁人相隔距離至少一公尺，時間可增加為兩小時。第三、四週則一公尺相處可增加為四小時。
 - (2)若家裡有十歲以下孩童或懷孕婦女，強烈建議三星期內不要接觸。
 - (3)多喝水增加尿液排泄，降低輻射殘留。
 - (4)如廁採坐姿，防止尿液潑灑於外增加輻射污染機會，如廁後多沖水幾次，以減

主題名稱	甲狀腺腫瘤術後的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K23	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	6/8

少輻射殘留。

(5)停止哺餵母乳 52 天，減少嬰兒由母乳受到放射性碘的傷害。

(6)婦女一年內不宜懷孕。

(八) 實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、 使用表單

(略)

五、 流程圖

(略)

六、 參考資料

(一) 王麒、楊宗霖(2021)·射頻消融術於甲狀腺腫瘤之應用·臨床醫學，87(3)，192-196。

(二) 胡月娟(2020)·內分泌系統疾病之護理·於劉雪娥總校閱，成人內外科護理（八版，691-707 頁，下冊），華杏。

(三) 蕭炳昆(2022)·甲狀腺癌症的診斷治療與最新進展·聲洋防癌之聲，171，31-37。

七、 附件

(略)

主題名稱	甲狀腺腫瘤術後的照護	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K23	版本	第 1.7 版	頁碼/總頁數	7/8

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
102.03.08	1.0	新制定。	102 年 03 月 08 日護理部照護標準委員會通過；102 年 03 月 08 日公布。
103.06.30	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
104.08.31	1.1	更新第六項參考資料。	104 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
105.08.31	1.2	1. 新增參考文獻出處於內文中。 2. 第六項參考文獻資料部份刪修。	105 年 08 月 31 日護理部照護標準委員會通過。
106.08.31	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.06.29	1.2	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
107.09.12	1.3	第二項新增（含中興分院）。	107 年 09 月 12 日護理長會議通過。
107.12.13	1.4	1. 與「護理部_A31000-Q03-W-K18_甲狀腺癌的照護」合併。 2. 第三項第一目、第四目之 3、第六目之 1(2)C、第七目之 4；之 10 新增說明內容。 3. 第三項第九日本辦法經委員會通過後公布實施，改為護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施。	107 年 12 月 13 日照護標準組會議通過；108 年 01 月 09 日護理長會議通過；108 年 01 月 22 日督導會議通過公布。
108.09.23	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
109.08.06	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
110.10.07	1.4	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
111.08.28	1.5	1. 第三項第四、六目內容修正。 2. 第六項參考資料修訂。 3. 內文參考文獻引用刪除。	111 年 10 月 06 日照護標準組會議通過；111 年 10 月 12 日護理長會議通過；111 年 11 月 08 日督導會議通過公布。

